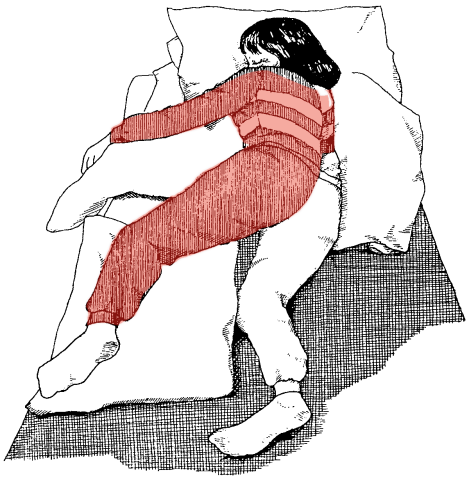
ГАУЗ ОЗП ГКБ № 8
Отделение ранней медицинской реабилитации (ОРМР)
Неврологическое отделение для больных с ОНМК (ПСО)

Реабилитация и уход после инсульта

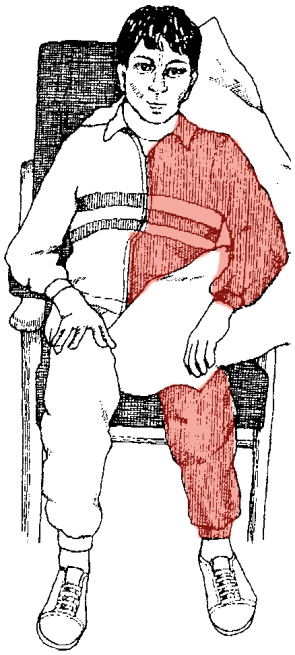
информация для пациентов и родственников — о главном, по порядку

шаг за шагом: от постели — к ходьбе



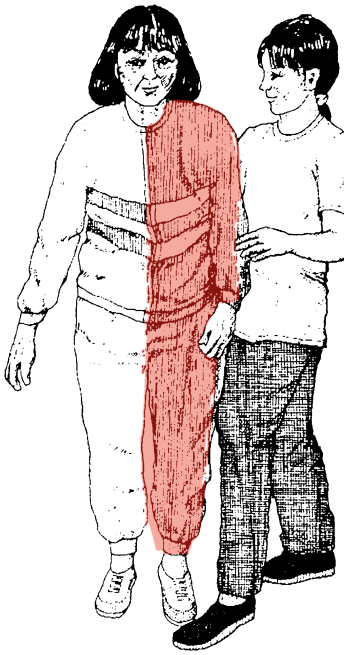
1. Лёжа на здоровом боку

↓



2. Сидя в кресле

→



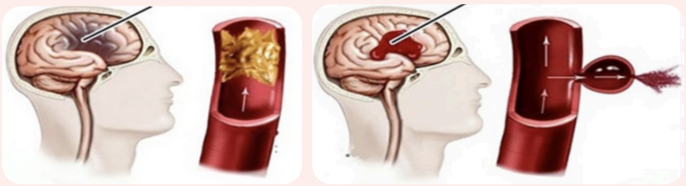
3. Ходьба с поддержкой

1 Что такое инсульт

Инсульт — острое нарушение кровообращения мозга: без кислорода и питания клетки мозга гибнут, и нарушается то, чем управлял этот участок.

Ишемический: участок мозга без крови

Геморрагический: кровоизлияние в мозг



Ишемический — около 80 %

Сосуд закупорен тромбом. Причины: атеросклероз — холестериновая бляшка, на которой растёт тромб; тромб, пришедший из сердца, например при мерцательной аритмии; нарушения свёртывания крови.

Геморрагический — около 20 %

Сосуд разорвался — кровоизлияние в мозг. Причины: **высокое давление** — главная; **аневризма** — выпячивание стенки артерии, которое может разорваться; **артериовенозная мальформация (АВМ)** — врождённый клубок неправильно соединённых сосудов; нарушения свёртывания крови. Кровоизлияние бывает внутримозговое и субарахноидальное — под оболочки мозга.

! ТИА — «малый инсульт»: признаки проходят за минуты–часы. Это предупреждение — всё равно сразу звоните 103 / 112.

Факторы риска

- **высокое давление**
- **высокий холестерин**
- **сахарный диабет**
- **лишний вес**
- **малоподвижность**
- **аритмия**
- **курение, наркотики**
- **алкоголь**
- **апноэ во сне**

Что может нарушиться

- движения и равновесие, чувствительность;
- речь, глотание, зрение;
- память, внимание, настроение;
- мочеиспускание и стул; быстрая утомляемость.

Восстановление возможно: здоровые участки мозга учатся брать на себя работу погибших. Нужны ранняя, регулярная реабилитация и терпение.

2 Коротко о главном
10 правил

🚶 Начинайте реабилитацию рано и занимайтесь **каждый день**.

⏰ Меняйте положение **каждые 2 часа**, днём и ночью.

⚠️ **Никогда не тяните** за больную руку и не поднимайте за подмышки.

🤝 Помогайте, а не делайте вместо — **ВМЕСТЕ**.

💪 Включайте больную руку и ногу во все дела.

👞 Берегитесь падений: удобная обувь, опора под рукой.

👕 Одевайте с больной стороны, раздевайте — со здоровой.

🪥 Воду проверяйте локтем, зубы чистите 2 раза в день.

❤️ Давление — **у каждого своя цель**: цифры назначает врач; лекарства — каждый день.

😊 Следите за настроением и берегите себя.

3 Как проходит реабилитация

этапы — по приказу № 788н

Начинается в первые 48 часов и продолжается дома. Активнее всего восстановление идёт в первые 3–6 месяцев, улучшение возможно и через год.

1 этап — отделение реанимации и интенсивной терапии, затем профильное отделение (ПСО). Занятия ведёт **ОРМР** — каждый день по 1–3 часа: положение, вертикализация, ходьба, речь, глотание, самообслуживание.

2 этап — круглосуточный стационар, отделение медицинской реабилитации: если нарушения выраженные (ШРМ 4–5) — каждый день по 3 часа и больше.

3 этап — дневной стационар, а также поликлиника, на дому и дистанционно — при умеренных нарушениях (ШРМ 2–3).

Мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК) — вместе с лечащим врачом и медицинской сестрой по медицинской реабилитации:



Врач ФРМ — куратор



Инструктор ЛФК



Медицинский логопед



Медицинский психолог



Эрго-реабилитация



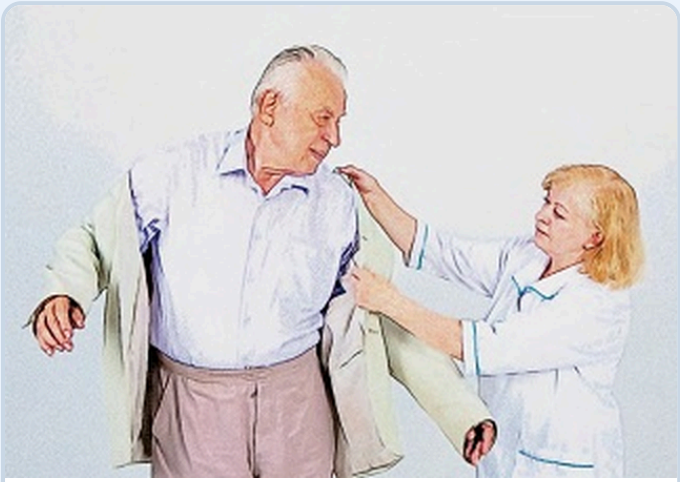
Пациент и семья — в центре

Цели — в индивидуальном плане медицинской реабилитации (ИПМР), по принципу **SMART**: конкретные, измеримые, достижимые, значимые и ограниченные по времени. Например: «через 2 недели пройти с тростью 10 м». **Пациент и семья — участники команды.**

Принципы реабилитации: раннее начало · систематичность и длительность · комплексность — работа всей команды · поэтапность.

4 Как помогать

ВМЕСТЕ, а не вместо



Помогайте, а одевается пациент сам

- договоритесь заранее и командуйте: «раз, два — встаём»;
- помогайте движениям, а не переносите своими силами;
- уберите лишнее, нужное положите ближе;
- стойте ближе, обычно — **с больной стороны**.

Поддержка каждый день

- одинаковый распорядок дня — спокойствие и пациенту, и вам;
- короткие тренировки утраченных навыков — несколько раз в день;
- нужно терпение: улучшение идёт медленно;
- хвалите даже за маленькие достижения.

Берегите свою спину

- устойчивая обувь без каблуков, свободная одежда;
- стопы на ширине плеч, ноги сгибайте, спина прямая, поворачивайтесь всем телом;
- устали — отдохните; тяжело — позовите второго помощника.

Наблюдайте и записывайте: движения, речь, глотание, настроение, сон, мочеиспускание и стул — рассказывайте врачу и медсестре.

Сначала научитесь у специалистов отделения: медсестра и инструктор покажут приёмы на вашем близком.



Поддержка каждый день

5 Правильное положение в постели

меняйте положение каждые 2 часа — днём и ночью



✓ **На здоровом боку**



✓ **На больном боку**



✓ **На спине — под углом 30–40°**



✓ **Сидя в кровати — под углом 90°**



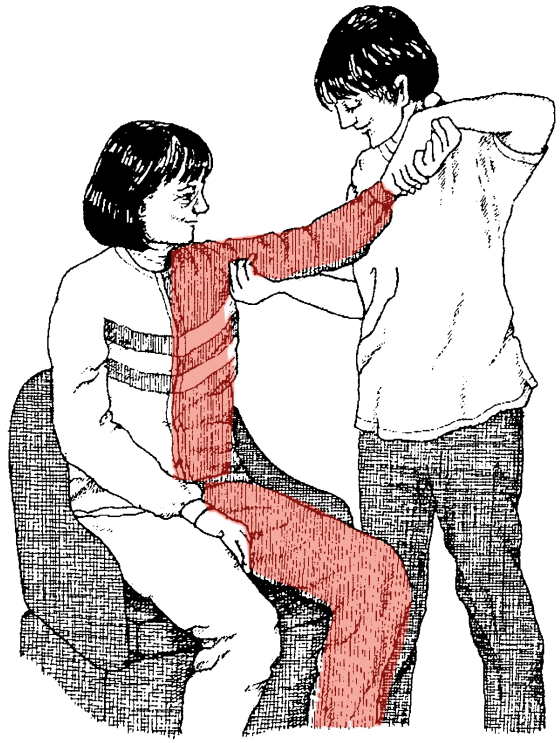
✓ **В кресле: кисть не свисает, стопы на полу**

на рисунках парализованная сторона заштрихована и выделена красным

- лёжа — **головной конец кровати приподнят на 30–40°**; под голову — не больше одной-двух подушек;
- **на здоровом боку:** полностью на боку, тело не изогнуто; подушка под спину; больная рука и нога — впереди на подушках;
- **на больном боку:** рука выпрямлена ладонью вверх, не лежать на руке; больная нога выпрямлена в бедре, чуть согнута в колене;
- **на спине — как можно меньше** (хуже дыхание, легко поперхнуться слюной, растёт тонус): под больное плечо — подушка 3 см, под больную ягодицу — 1,5 см;
- **сидя в кровати:** вес на обеих ягодицах, таз ровно; больная нога не развёрнута наружу;
- **в кресле:** сидеть симметрично, бёдра на сиденье, стопы на полу или подставке; локоть на подушке.

Золотые правила: голова на одной линии с туловищем; больное плечо вынесено вперёд; в больной руке ничего не лежит; стопа ни во что не упирается.

6 Берегите больное плечо



✓ **Под плечо и за локоть**



✓ **Одевание: 1 — рукав на больную руку, 2 — на плечо, 3 — здоровая рука**

Мышцы больной руки слабые и плохо держат плечевой сустав: рука тянет его вниз — возникают подвывих и боль. Боль в плече легче предупредить, чем лечить.

- поднимайте руку, поддерживая **под плечо и за локоть**;
- пациент сам поддерживает больную руку здоровой ладонью под локоть;
- лёжа — плечо и рука на подушке, плечо выведено вперёд;
- сидя — рука на подушке, столике или подлокотнике, кисть не свисает;
- одевая, сначала продевайте больную руку и натягивайте рукав до плеча — так плечо не тянется;
- при вставании и ходьбе — поддержка руки; бандаж или ортез подбирает специалист;
- упражнения для плеча — плавно и без боли; выше уровня плеча — только с инструктором.

Боль в плече, отёк кисти, рука «тянет» — скажите врачу: помогут лечение положением, кинезиотейпирование, электростимуляция, при спастичности — ботулинотерапия.

7 Кожа и пролежни

профилактика — по ГОСТ Р 56819-2015



- **на спине:** затылок, лопатки, локти, копчик и крестец, пятки;
- **на боку:** ухо, плечо, бедро, колено, лодыжка, пальцы ног;
- **полусидя:** затылок, лопатки, копчик, седалищные кости, пятки;
- **сидя в кресле:** лопатки, копчик, бедро, седалищные кости, пятки.

Стадии пролежня



1 стадия
покраснение не проходит после снятия давления, кожа цела



2 стадия
пузырь, ссадина, неглубокая рана



3 стадия
глубокая рана до мышцы, могут быть выделения



4 стадия
разрушены все мягкие ткани, видны сухожилия или кость

Пролежень появляется за несколько часов, а лечится неделями. **1 стадию можно остановить** — снимите давление и скажите медсестре.

- меняйте положение **каждые 2 часа**; сидя — чаще меняйте позу;
- противопролежневый матрас; подушки между коленями и лодыжками; пятки — на весу;
- перемещайте, приподнимая, — не тяните по простыне; простыня без складок и крошек;
- кожа чистая и сухая: после туалета подмыть, промокнуть, нанести защитный крем;
- не растирайте и не массируйте покрасневшие места;
- питание с достаточным белком и питьё — коже нужны силы;
- осматривайте кожу утром и вечером: покраснение не проходит за 30 минут — **начало пролежня**, скажите медсестре;
- грелки на больную сторону — нельзя: она плохо чувствует ожог.

8 Повернуться и сесть в кровати



Поворот на больной бок



К изголовью



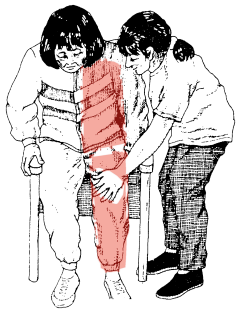
Сесть

- **повернуться на больной бок:** согнуть колени, больную руку — на грудь, повернуть голову и оттолкнуться здоровой ногой; помощник — с больной стороны, держит за здоровое плечо, колено или таз;
- **к изголовью:** сесть, ноги согнуты; опираясь на здоровую руку и пятку, понемногу двигаться назад; помощник — рука вокруг таза, другая под больным бедром, вместе, по команде;
- **сесть:** повернуться на больной бок, спустить ноги, здоровой ногой помогая больной, оттолкнуться здоровой ладонью от матраса;
- если трудно — помощник поддерживает под больную лопатку и за здоровое бедро.

9 Встать и пересесть



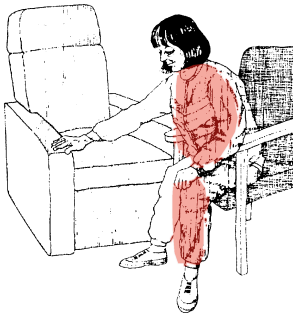
Встать сам



Чуть помочь



Больше помочь



Пересесть

- **встать:** сдвинуться на край сиденья, стопы на ширине плеч, чуть под себя; наклониться вперёд — плечи над коленями; оттолкнуться и выпрямиться;
- **помощник** с больной стороны: рука на спине, другая — на больном колене; больше помощи — лицом к пациенту, держит за таз, коленями поддерживает больное колено; здоровая рука пациента — на плече помощника;
- **пересесть:** второе кресло — под прямым углом, лучше со здоровой стороны; взяться за дальний подлокотник, привстать, повернуться и медленно сесть поглубже.

10 Ходьба и лестница



Ходьба



Вверх — здоровой



Вниз — больной

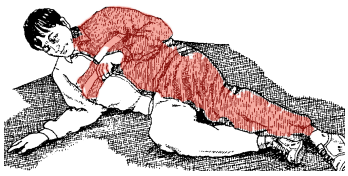
- **каждый день:** стоять у опоры, ходить по комнате, потом по коридору и на улице; нагрузку увеличивать постепенно;
- **опора:** поручень → ходунки или трость с 4 опорами → трость → без опоры; трость — в здоровой руке, высота — до запястья;
- **стопа «свисает»** — специалист подберёт ортез;
- **лестница:** вверх — сначала здоровая нога, вниз — больная; помощник с больной стороны: вверх — сзади, вниз — впереди; держаться за перила;
- **упражнения для ноги** 1–2 раза в день: стопы на себя — от себя, «мостик», встать — сесть со стула, перенос веса у опоры.

Дом без падений: уберите коврики и провода, включайте ночник, обувь с задником, опора — под рукой.

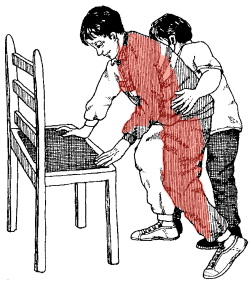
11 Если пациент упал



1



2



3

Не торопитесь поднимать: сделайте несколько вдохов, проверьте, нет ли травмы, особенно с больной стороны.

1. повернуться на здоровый бок: больную руку — на живот, колени согнуть;
2. опереться на здоровый локоть и сесть боком;
3. встать на колени перед устойчивым стулом, опереться предплечьями, поставить здоровую ногу и встать; повернуться и сесть.

! Сильная боль, не может опереться на ногу, удар головой, не встаёт после нескольких попыток — не поднимайте, вызывайте скорую: **103 / 112**.

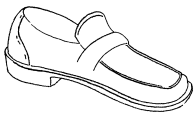
12 Одевание и обувь



1. Рукав — на больную руку



2. Потом — здоровую



Обувь с задником



Петля на молнии

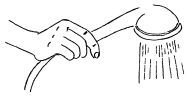
Одевать — с больной стороны, раздевать — со здоровой

- одеваться сидя на устойчивом стуле с подлокотниками; одежду сложить по порядку;
- рубашка: рукав — на больную руку до плеча, ворот — за спину, здоровую руку — во второй рукав;
- брюки: сидя — штанину на больную ногу, потом на здоровую; встать с опорой — помощник страхует;
- одежда свободная, застёжка спереди, липучки, резинка вместо ремня; носки без тугой резинки;
- обувь без шнурков или на липучках, с задником, на низком нескользящем каблуке; рожок с длинной ручкой.

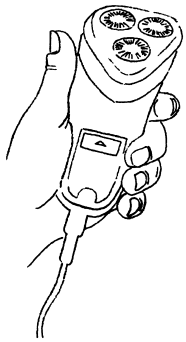
13 Мытьё и гигиена



Вода — локтем



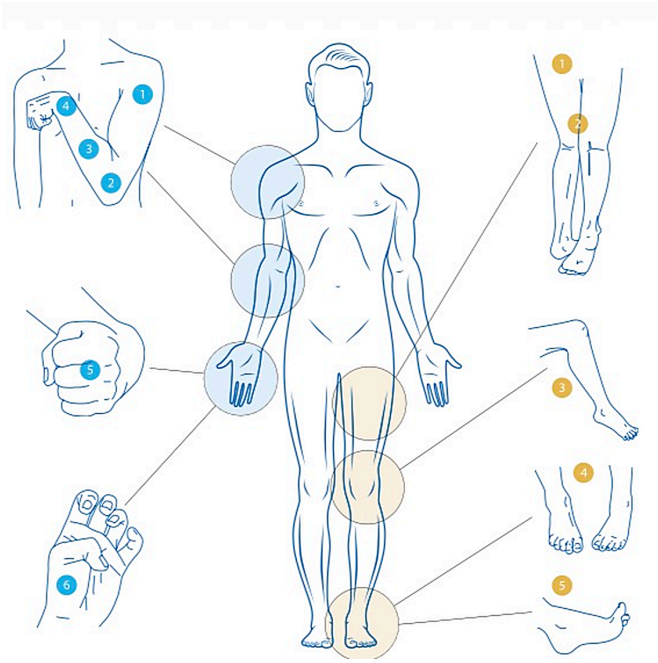
Ручной душ



Бритьё

- мыться сидя — на стуле для душа или сиденье для ванны; нескользящий коврик, поручни; дверь не запирать;
- сначала холодная вода, потом горячая; около 37 °C — проверять локтем или термометром;
- зубы и язык — утром, вечером и после еды; протезы снимать и мыть;
- бритьё — электробритвой; ногти — раз в неделю, после мытья;
- лежачего — мыть по частям и сразу вытирать; после туалета — подмыть и нанести защитный крем.

14 Рука и спастичность



Как проявляется спастичность

Спастичность — повышенный тонус мышц: рука или нога «тянет», её трудно согнуть или разогнуть. Бывает у 25–40 % пациентов в первый год; первые признаки — через 2–3 недели, нарастает за несколько месяцев. Мешает одеваться, мыться, ходить, вызывает боль.

Рука

плечо прижато к телу и повёрнуто внутрь, локоть согнут, кисть согнута и сжата в кулак, большой палец прижат к ладони.

Нога

бёдра сведены («ножницы»), колено разогнуто — «не гнётся», стопа повёрнута внутрь, большой палец поднят вверх.

Как лечат

- правильное положение, растяжка и упражнения каждый день;
- **ботулинотерапия** — основной метод: уколы в мышцы снимают спазм и облегчают занятия;
- ортезы и шины, кинезиотейпирование;
- новые методы: ударно-волновая терапия, электро- и магнитная стимуляция, роботизированные тренажёры;
- таблетки — только по назначению врача; при тяжёлой спастичности — баклофеновая помпа.

Чем раньше заметить, тем легче лечить: при подозрении на спастичность сразу скажите врачу.

Рука и кисть

Рука восстанавливается, только если ею пользоваться: чашка, пуговицы, ложка, письмо. Упражнения 2–3 раза в день: разогнуть пальцы, кисти в «замке», мяч, перекладывать фасоль, «кулак — ребро — ладонь».

15 Речь и глотание

помогает медицинский логопед

1 из 3 **пациентов — нарушение речи**

3 часа **за это время после поступления проверяют глотание**

Речь и глотание восстанавливает **медицинский логопед**. Все памятки выдаёт специалист **в индивидуальном порядке** — в зависимости от нарушения.

Афазия

нарушение речи как языка: трудно подобрать слово, понимать быструю речь, читать, писать, считать. Интеллект, память о близких, чувства сохранены.

Дизартрия

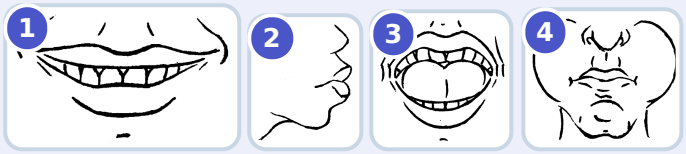
нечёткое, «смазанное» произношение из-за слабости мышц губ, языка, гортани.

Как общаться

- назовите по имени, сядьте напротив, на уровне глаз; выключите телевизор;
- говорите медленно, короткими фразами, обычным голосом — кричать не нужно;
- вопросы с ответом «да — нет» или с выбором: «Чай или сок?»;
- помогайте жестами и картинками; дайте время на ответ, не перебивайте;
- слово «не вспоминается» — подскажите первый слог: «Ча-…» — «Чашка!».

Занятия

с логопедом — по 10–40 минут; самостоятельно — 2–3 раза в день; гимнастика для губ и языка — 2–3 раза в день по 5–7 минут; и живое общение весь день.



1 «улыбка» · 2 «трубочка» · 3 «зевок» · 4 «дутыши»

Нарушение глотания — дисфагия

- кашель или поперхивание во время еды;
- «булькающий», влажный голос после глотка;
- пища выпадает изо рта или остаётся за щекой;
- температура, хрипы после еды, частые пневмонии.

! Пища может попадать в дыхательные пути и без кашля — «тихая» аспирация. Поэтому глотание проверяют специалисты, а кормить можно только после их разрешения.

16 Средства ухода

Постель: функциональная кровать с поручнями, противопролежневый матрас, подушки и валики для положения, прикроватный столик, впитывающие пелёнки.

Гигиена: подгузники или впитывающие трусы, пенка для мытья без воды, защитный крем, влажные салфетки, одноразовые перчатки.

Туалет и ванна: кресло-туалет, стул для душа или сиденье для ванны, поручни, нескользящий коврик.

Еда и лекарства: поильник, кружка с двумя ручками, ложки с толстыми ручками, тарелка с бортиком, таблетница.

Передвижение: трость, ходунки, кресло-коляска; высота трости и ходунков — до запястья опущенной руки.



Матрас от пролеж-ней



Ванночка для головы



Ложка с толстой ручкой

17 Технические средства реабилитации

ТСР — изделия, которые устраняют или компенсируют стойкие ограничения жизнедеятельности. **Цель** — удобная, доступная среда и независимая жизнь.



1. **для передвижения:** кресло-коляска, ходунки, костыли, трости;
2. **для быта:** душевые табуреты, сиденья для ванны, поручни, насадки на унитаз, приборы с толстой ручкой, фиксаторы посуды, поильники;
3. **для профилактики осложнений:** противопролежневые матрасы, накроватные столики, бруски для высоты кровати, валики и подушки для лечебного положения, дуги для одеяла.

Средства подбирает специалист — не покупайте наугад, до консультации с лечащим врачом. При инвалидности ТСР из федерального перечня положены по ИПРА: Социальный фонд России выдаёт их, компенсирует покупку или выдаёт электронный сертификат.

18 Социально-бытовая реабилитация



Цель — вернуть самостоятельность в быту: одеваться, мыться, готовить, выходить из дома и общаться.

Эргореабилитация

Специалист по эргореабилитации тренирует бытовые навыки в отделении и подскажет, как приспособить дом: поручни, убрать пороги и коврики, свет и ночники, кровать и стул нужной высоты, нужные вещи — под рукой со здоровой стороны.

Инвалидность и ИПРА

После выписки из стационара, если ограничения сохраняются, **врач-невролог поликлиники** по показаниям направляет на медико-социальную экспертизу (МСЭ). При установлении инвалидности составляют индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА): какие реабилитационные мероприятия и технические средства положены.

Социальная поддержка

- органы социальной защиты: помощь социального работника на дому, сиделка, отделения дневного пребывания, пункты проката ТСР;
- Социальный фонд России — ТСР и компенсации по ИПРА;
- школа для родственников — научат приёмам ухода и безопасного перемещения.

Возвращение к делам

- посильные домашние дела — тоже тренировка: накрыть на стол, разобрать бельё, полить цветы;
- прогулки, общение, любимые дела — по силам, каждый день;
- за руль и к работе — только после разрешения врача.



Домашние дела



Общение



Прогулки

19 Настроение, память, деменция

медико-психологическая помощь

30–50 % пациентов — эмоциональные нарушения

1 из 3 переносит депрессию — она лечится

до 83 % нарушения памяти, внимания, мышления

Это следствие болезни мозга, а не слабость характера. Консультация психолога — обычная часть лечения после инсульта.

Скажите врачу, если 2 недели и дольше

- подавленность, плаксивость; ничто не радует;
- нарушены сон и аппетит;
- чувство вины, мысли «я обуза»; тревога, раздражительность.

! Срочно скажите врачу: мысли о нежелании жить, спутанность, видит или слышит то, чего нет.

Медицинский психолог — в команде

Оценит настроение (HADS) и память (MoCA), научит приёмам спокойного дыхания, тренирует память и внимание, поможет близким.

Помогите себе сами

- **дыхание «4 — 8»:** вдох носом на 4 счёта, медленный выдох губами трубочкой на 6–8 счётов, 3–5 раз;
- **тревога — «5-4-3-2-1»:** назовите 5 предметов, которые видите, 4 ощущения тела, 3 звука, 2 запаха, 1 вкус;
- режим дня, маленькие цели, общение и любимые дела.

Память

Часы и календарь на виду, таблетница, списки и будильник, режим дня, одно дело за раз; тренировка 15–20 минут 1–2 раза в день.

Деменция

Безопасный привычный дом, спокойная речь короткими фразами, режим дня; не спорьте — мягко переключайте; лекарства — только назначенные.



Поддержка близких



Воспоминания

Близким: как в самолёте — сначала маску себе. Усталость, бессонница, раздражение — признаки выгорания: просите помощи.

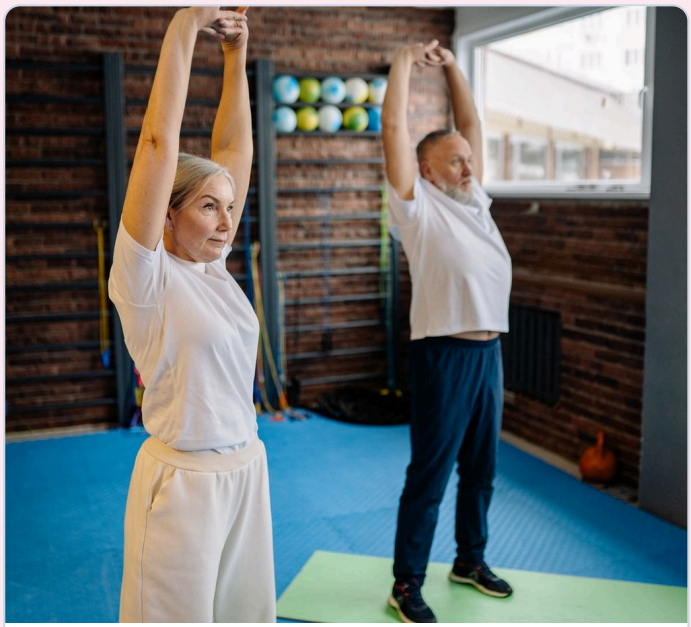
20 Профилактика инсульта
первичная и вторичная

Первичная — для всех, в том числе родственников: диспансеризация, знайте своё давление, холестерин и сахар. **Вторичная** — после инсульта: лечение и образ жизни — на всю жизнь.

- **Давление** — своя цель, лекарства каждый день.
- **Холестерин:** «плохой» (ЛНП) после инсульта — ниже 1,4 ммоль/л; статины — долго, не прерывая.
- **Сахарный диабет:** контроль сахара и гликированного гемоглобина, лечение у эндокринолога.
- **Масса тела:** индекс массы тела 18,5–24,9; талия — у мужчин меньше 102 см, у женщин меньше 88 см.
- **Питание:** гиполипидемическая диета — меньше животных жиров и соли, больше овощей, рыбы и клетчатки (см. «Еда и питьё»).
- **Курение** удваивает риск — бросайте полностью.
- **Алкоголь** — откажитесь или резко сократите.
- **Движение:** быстрая ходьба — не меньше 10 минут 4 раза в неделю; каждые 30 минут сидения — встаньте на 3 минуты.
- **Неровный пульс** — к врачу: мерцательная аритмия повышает риск инсульта.
- **Лекарства** — каждый день, без перерывов, не отменяйте сами.
- **Наблюдение:** после выписки — регулярно у врача в поликлинике, анализы на холестерин и сахар.

своя цель давления — назначает врач	**< 1,4** ЛНП, ммоль/л
18,5–24,9 индекс массы тела	**102 / 88** талия, см: мужчины / женщины

Индекс массы тела = вес (кг) : рост² (м). Пример: 80 кг, рост 1,70 м → 80 : 2,89 ≈ 27,7 — есть лишний вес.



Движение каждый день



Контроль у врача

21 Еда и питьё
безопасно и полезно

Безопасно

- кормить и поить — **только после проверки глотания** и разрешения врача;
- есть сидя — в кровати под углом 90° или в кресле, голова чуть вперёд;
- маленькими порциями — пол чайной ложки, без спешки; телевизор выключить;
- после еды — проверить рот, посидеть 30 минут, почистить зубы;
- кашель, поперхивание, «булькающий» голос — прекратите кормление и скажите врачу или логопеду.

Гиполипидемическая диета — меньше холестерина

Правило тарелки



- ½ — овощи и зелень
- ¼ — крупы, хлеб с отрубями
- ¼ — рыба, птица без кожи, бобовые

✓ Можно

овощи, зелень	фрукты, ягоды	крупы
хлеб с отрубями	бобовые	рыба 2 раза в неделю
птица без кожи	нежирное молочное	расти-тельное масло
орехи — горсть	вода	лимон и травы вместо соли

× Ограничить или нельзя

соль — до 5 г	сало, жирное мясо	колбасы, сосиски
сливочное масло	жирный сыр	торты, выпечка
жареное, фастфуд	сладости	алкоголь

22 Давление



Правильно: сидя за столом, рука на столе, манжета на плече

цель — своя для каждого

Для большинства — ниже 130/80 мм рт. ст.; людям старше 80 лет и при других болезнях цифры назначает врач.

Как измерять

1. утром и вечером, в одно и то же время;
2. сидя, после 5 минут отдыха; за 30 минут — без кофе и курения;
3. рука на столе на уровне сердца, манжета — на голое плечо;
4. 2 измерения с перерывом 1–2 минуты, не разговаривать;
5. записывать в дневник и показывать врачу.



Манжета — на голое плечо

Дата	Время	Давление	Пульс

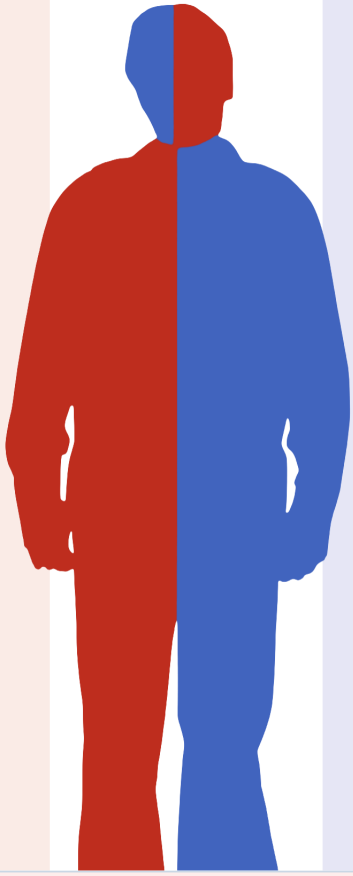
- таблетки — каждый день, даже если давление нормальное; не отменяйте сами;
- меньше соли, больше движения, нормальный вес — давление снижается.

! Выше 180/110, резко упало, сильная головная боль или головокружение — вызывайте скорую: **103 / 112**.

23 Когда звать врача

Повреждение правого полушария головного мозга

- Паралич правой половины тела
- Нарушение речи
- Нарушение поведения (медлительность, осторожность)
- Нарушение памяти (речевой)



Повреждение левого полушария головного мозга

- Паралич левой половины тела
- Нарушение пространственного восприятия
- Нарушение поведения (вспыльчивость, импульсивность)
- Нарушение памяти (зрительной)

Каждое полушарие мозга управляет противоположной половиной тела. Человек на рисунке стоит лицом к вам. Признаки — того же цвета, что и поражённое полушарие.

Признаки инсульта — «Лицо, Рука, Речь, Время»



1. Нарушение чувствительности



2. Нарушение речи и понимания

3. Головокружение, нарушение координации



4. Нарушение зрения, двоение

5. Слабость руки, ноги, несимметричная улыбка



6. Сильная внезапная головная боль

103 / 112

вызывайте скорую — даже если признаки прошли

Сразу вызывайте скорую

- внезапно ослабли рука или нога, перекосило лицо, нарушилась речь;
- резкая головная боль, рвота, судороги, потеря сознания;
- одышка, боль в груди;
- падение с сильной болью или ударом головы;
- давление выше 180/110.

Пока едет скорая: уложите, приподняв голову и плечи; расстегните тесную одежду; не давайте еду, питьё и таблетки; запишите время начала.
Диспетчеру скажите: адрес, возраст, что случилось и когда начались признаки.

Ваша мультидисциплинарная реабилитационная команда

заведующая ОРМР, врач физической и реабилитационной медицины (ФРМ)	**Давыдова Наталья Владимировна**
заведующий ПСО ОНМК	**Клепиков Евгений Юрьевич**
медицинский психолог	**Мазур Егор Андреевич**
медицинский логопед	**Кочурова Анастасия Олеговна**
инструктор-методист ЛФК	**Борисенко Наталья Светославовна**
инструктор ЛФК	**Ширяева Юлия Сергеевна**
лечащий врач	**у каждого пациента — свой**

Памятка — в телефоне

Наведите камеру телефона на QR-код: памятку можно читать, сохранить и отправить родным.

Данная памятка выдана в период госпитализации в неврологическом отделении для больных с ОНМК.

Терпение и правильные движения делают уход легче, а восстановление — быстрее!

При признаках инсульта — сразу звоните 103 или 112

Составлено в соответствии с приказами Минздрава России от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых» (в ред. приказа от 16.09.2025 № 567н), от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», от 28.02.2023 № 81н (медицинская реабилитация на дому), клиническими рекомендациями «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых» (2024; разработчики — Всероссийское общество неврологов, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, Союз реабилитологов России и др.), ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней». Рисунки — из руководства «Начните двигаться!», «Справочника для тех, кто ухаживает за больными инсультом», брошюры «Восстановление после инсульта: понятным языком — о самом главном» (реабилитацияпослеинсульта.рф); цветные значки — Fluent Emoji (Microsoft, лицензия MIT). Не заменяет назначений лечащего врача.